

Péterfy Sándor Utcai Kórház
1076, Budapest, Péterfy Sándor
utca 8-20
Telefon: 461-4700

LABORATÓRIUMI LELET

Sürgősségi Betegellátó Osztály
és Klinikai Toxikológia
SBO-KTOX
Osztályvezető: Dr. Tóth Ferenc

Páciens neve: Frodó Péter

Taj-száma: 121 236 734

Születési dátum: 2004. 08. 20.

Lakcím: 1089 Budapest, Diószei

Sámuel utca 38-42.

Nem: Férfi

Napi sorszám: 9

Beutaló orvos: 21964

Beutaló egység: 9124537223
Toxikológia

Dátum: 2026. 01. 21.

Azon.: 1003635614

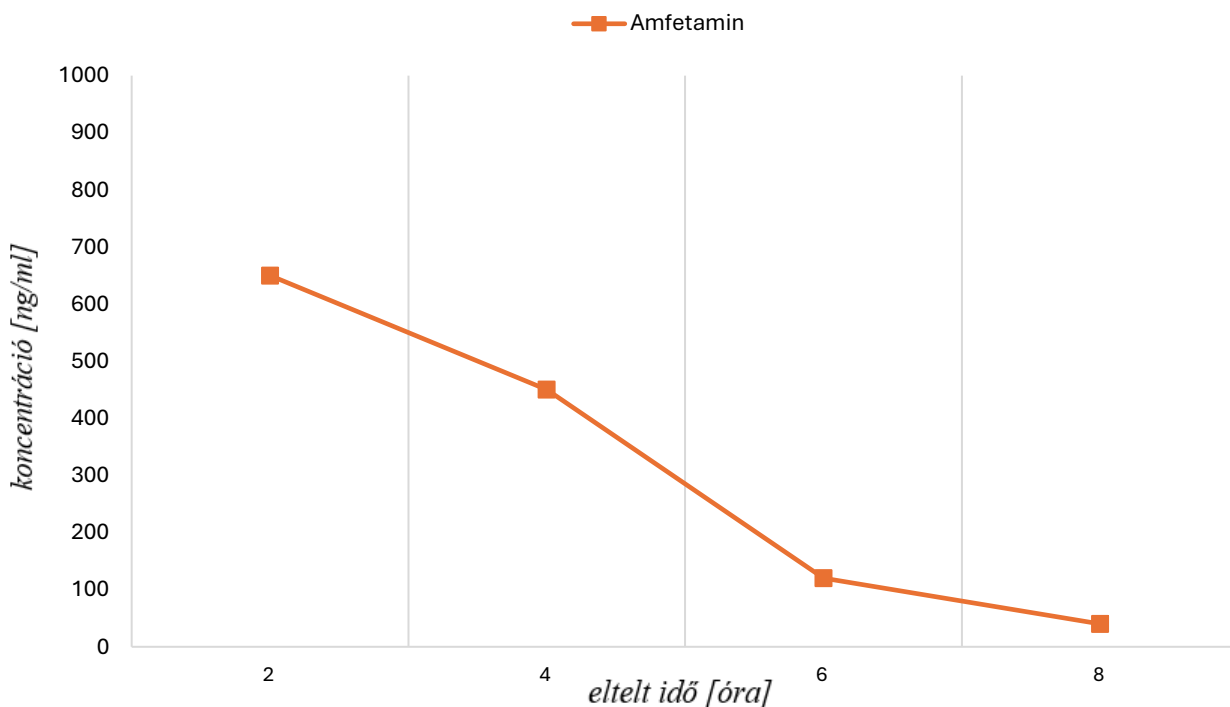
KLINIKAI KÉMIA ÉS HEMATOLÓGIA

Kért vizsgálatok:	Eredmény: mértékegység		Referencia érték:
WBC (Fehérvérsejt)	15,40	G/L	4,0 - 10,0 (H)
RBC (Vörösvérsejt)	5,10	T/L	4,5 - 5,9
Hemoglobin	158	g/L	135 - 175
Hematokrit	0,46	L/L	0,40 - 0,52
PLT (Trombocita)	210	G/L	150 - 400
Vércukor (éhom)	8,9	mmol/l	3,6 - 6,0 (H)
Nátrium	144	mmol/l	136 - 145
Kálium	5,8	mmol/l	3,5 - 5,1 (H)
Kreatin-kináz (CK)	>2000	U/L	40 - 190 (H)
S-Etanol (Véralkohol)	0,43	g/l	< 0,20 (Pozitív)
CRP (Gyulladásos marker)	4,2	mg/l	0,0 - 5,0

SÜRGŐSSÉGI TOXIKOLÓGIAI PANEL

A szűrés immunkémiai módszerrel történt

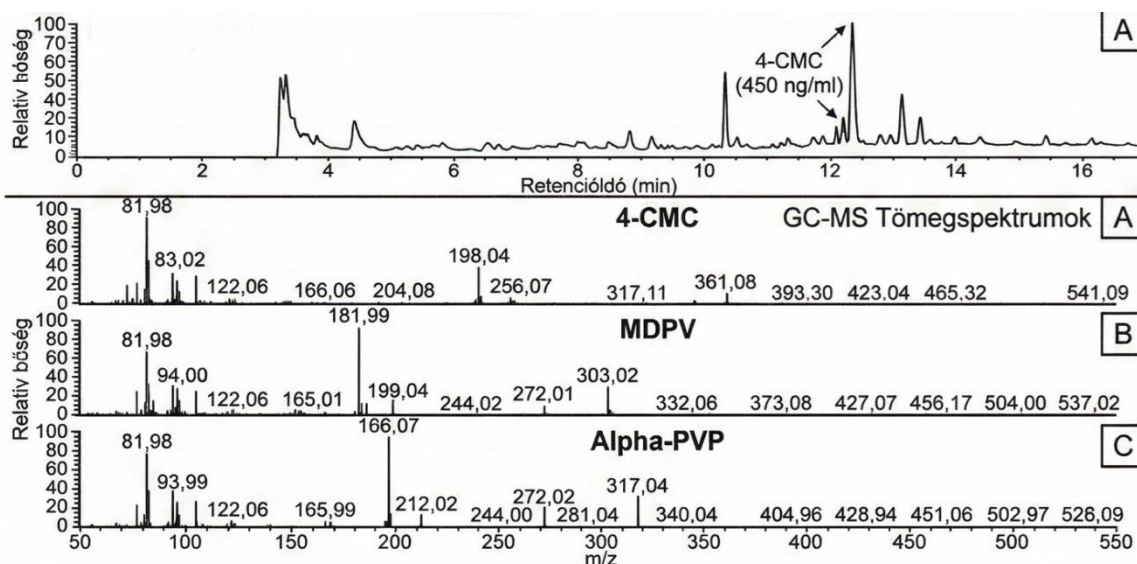
Kért vizsgálatok:	Eredmény: Mértékegység	Határérték
Amphetamine	650 ng/ml	500 ng/ml
MDMA	< 100 ng/ml	500 ng/ml
THC-COOH	< 10 ng/ml	50 ng/ml
Benzodiazepin	< 10 ng/ml	200 ng/ml
Cocaine Metabolite	< 50 ng/ml	300 ng/ml
Opioidok	< 100 ng/ml	2000 ng/ml
Methadone	< 25 ng/ml	300 ng/ml



GÁZKROMATOGRÁFIA-TÖMEGSPEKTROMETRIA

Toxikológia Panel - Kiegészítés

Kért vizsgálatok:	Eredmény: Mértékegység	Határérték
LSD (Lizergsav-dietilamid)	0,3 ng/ml	0.5 ng/ml
25I-NBOMe	0,1 ng/ml	0.5 ng/ml
2-oxo-3-hydroxy-LSD	0,5 ng/ml	1.0 ng/ml
Pszilocibin	< 1 ng/ml	2 ng/ml
Ketamin	< 10 ng/ml	50 ng/ml
Koffein	30 ng/ml	25ng/ml
Amfetamin	659 ng/ml	500 ng/ml
4-CMC	447 ng/ml	1 ng/ml



ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉS

A klinikai kép és a GC-MS vizsgálat eredményei alapján a páciens állapota akut kombinált stimuláns intoxikációnak felel meg. A szervezetben kimutatott jelentős mennyiségű 4-CMC (4-chloromethcathinone) és amfetamin együttes jelenléte súlyos szimpatomimetikus toxidrómat idézett elő, amely magyarázza a felvételkor észlelt extrém neurológiai és kardiális tüneteket, úgymint a pszichomotoros agitációt és a kritikus tachycardiát.

Különös figyelmet érdemel az extrém magas CK (Kreatin-kináz) érték, amely a tartós fizikai hyperaktivitás és a stimulánsok okozta izomfeszülés következtében kialakuló rhabdomyolysis diagnózisát támasztja alá. A toxikus anyagok kombinációja és a kialakult anyagcsere-zavar fokozott kockázatot jelent az akut veseelégtelenségre és a májfunkciókra, ezért a speciális laboratóriumi vizsgálat elvégzése indokolt volt a pontos azonosításhoz.

Diagnózis:

- **F15.00**
- **T43.6**
- **R45.6**
- **M62.8**
- **R50.9**

Javaslat és további teendők:

A páciens kritikus állapota és a potenciálisan életveszélyes szövődmények - különösen az akut veseelégtelenség és a szívritmuszavar - kockázata miatt azonnali átszállítás indokolt az Intenzív Terápiás Osztályra. Az ellátás során folyamatos kardiális monitorozás, valamint emelt szintű, agresszív intravénás folyadékpótlás megkezdése szükséges a veseelégtelenség megelőzése és a myogloblin kiürítése érdekében. A sürgősségi ellátás jellegére való tekintettel a kezelés idejénél az óra és perc pontos dokumentálása elengedhetetlen. A vizeletmennyiség szoros követése, továbbá a pupillareflexek és az izomtónus rendeződéséig tartó folyamatos neurológiai kontroll kötelező. Az agresszív viselkedés és az agitáció kezelésére szükség esetén szedáció alkalmazandó.

A beteg állapotának stabilizálódását követően kötelező addiktológiai és pszichiátriai konzílium összehívása, valamint a páciens szakirányú gondozásba vétele.